

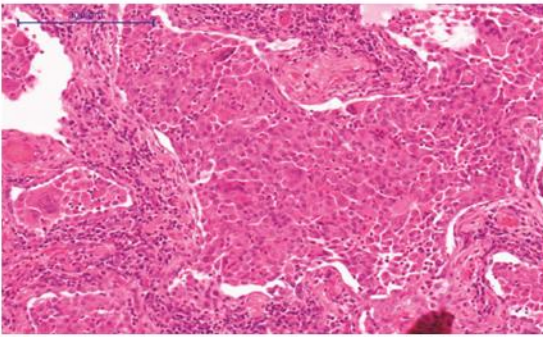


図3 DIP患者の外科的肺生検による肺病理組織写真
気腔内へ肺胞マクロファージが広範、高度に浸出し、背景に軽度の構造変化を伴った線維化をみる。

b) RB-ILD

RB-ILDとDIP（疾患名）は共通点も多く、RB/DIPパターン（病理パターン）は同一患者に共存することもあり、両者の病変は質的な違いではなく量的な違いで同じスペクトラムの疾患と考える報告もある¹³⁾。しかし、明らかにRB-ILDからDIPに進展した症例は報告されず、現時点ではRB-ILDとは独立した疾患と考えられている。喫煙率が100%に近いRB-ILDとの異同には議論がある。

症候・身体所見¹¹⁾

症状は乾性咳嗽や、労作時呼吸困難を認める。約半数に胸部聴診上では捻髪音（fine crackles）を、1/3でパチ指を認める。

診断・検査⁴⁾

a 画像所見

胸部X線写真（図4）では肺容積変化が乏しく、両側中下肺に優位のすりガラス陰影を認める例が多いが¹¹⁾、20%までが正常所見である。胸部HRCT画像所見は、下肺末梢優位の分布を示す例が多い。早期例ではHRCT画像所見はすりガラス陰影が主体で、すりガラス陰影の内部に、小嚢胞が高頻度に認められる（図5）。この嚢胞はすりガラス陰影が消失しても残存し、DIPに特徴的な画像所見と報告された線維化傾向が残る症例もある。画像で鑑別になる疾患は、特発性あるいは膠原病に合併したNSIP、器質性肺炎、RB-ILD、過敏性肺炎、好酸球性肺炎である。

b その他の検査

呼吸機能では拘束性障害、拡散能低下を示すことが多いが、気腫合併例では拡散能のみ低下する例もある。気管支肺胞洗浄液でマクロファージの細胞数上昇、細胞分画でのリンパ球/好酸球増多を認める¹¹⁾。

治療と予後

喫煙例にはまず禁煙指導を行う。ただし必ずしも禁



図4 DIP患者の胸部X線写真
肺容積に変化はなく、両側下肺に優位のすりガラス陰影を認める。

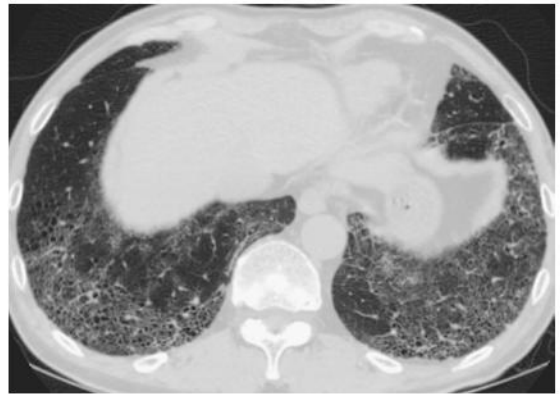


図5 DIP患者の胸部HRCT
肺胞腔内にマクロファージが充満する所見を反映したすりガラス影を認め、内部に多数の嚢胞形成を認める。
（図2と同一症例：防衛大学放射線科：杉浦弘明先生のご厚意による）

煙のみで寛解が得られるとは限らず、副腎皮質ステロイド薬の投与が必要になる例もある。副腎皮質ステロイド薬の反応性は良好な例が多く、初期量はPSL 0.5 mg/kg/dayで開始して漸減する¹¹⁾。

予後は比較的良好であり、10年生存率は64~100%と報告されている^{14,15)}。1978年Carringtonの報告では、DIPの5年/10年生存率がそれぞれ93/51%であり、長期予後は不良だった¹⁶⁾。しかし、2000年Travisの報告では10年生存率が100%と予後良好だった¹⁵⁾。日本での31例の検討では一部線維化病変が進行する例があり10年生存率78%だった¹⁴⁾。生存率の違いは肺胞壁の線維化の程度によると考えられる。肺癌で死亡する例もある。喫煙の再開や受動喫煙、副腎皮質ステロイド薬中止で再発することがある。外科的肺生検後に急性増悪を発症した例もある。